

TALLER SOCRÁTICO: ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SNC

GUÍA DEL ESTUDIANTE

Docente: Dr. Alcy Torres | Semestre 2026-2 | Semana 14 | Marco: KNOW → REASON → ACT

Integrantes: _____

Grupo N°: _____

Fecha: 22 / 09 / 2026

Viñeta Clínica de Entrada

- Paciente:** Femenina de 27 años, diseñadora gráfica, diestra, sin antecedentes mórbidos conocidos.
- Motivo de consulta:** «Desde hace 5 días siento las piernas dormidas desde el ombligo hacia abajo y, cuando agacho el cuello, me baja una corriente por la espalda.»
- **Enfermedad actual:** Parestesias ascendentes en miembros inferiores instaladas en 48 h; estables desde hace 3 días. Urgencia miccional sin incontinencia. Afebril, sin síntomas infecciosos ni respiratorios previos.
 - **Signo referido:** Sensación eléctrica fulgurante que desciende por el raquis al flexionar activamente el cuello.
 - **Antecedente clave (interrogatorio dirigido):** Hace **14 meses** presentó visión borrosa en **ojo derecho** con **dolor al movimiento ocular** durante 3 semanas. Fondo de ojo fue reportado normal en ese momento; remitió espontáneamente sin estudios.
 - **Otros síntomas:** Fatiga vespertina crónica. Al bañarse con agua muy caliente nota que la visión del ojo derecho «se empaña» transitoriamente por unos minutos.

Examen Físico y Neurológico Dirigido

Signos Vitales	T: 36,6 °C, PA: 112/70 mmHg, FC: 74 lpm, SatO ₂ : 98 % aire ambiente. Afebril.
Vía Visual	AV: OD 20/30, OI 20/20. Desaturación al color rojo en OD. Linterna oscilante: Defecto Pupilar Aferente Relativo (DPAR / Pupila de Marcus Gunn) en OD. Fondo de ojo: Palidez temporal del disco óptico en OD. OI normal.
Motilidad Ocular	Mirada conjugada hacia la izquierda: limitación de aducción en OD + nistagmo monocular en abducción en OI. Convergencia pupilar y ocular rigurosamente conservadas.
Motor y Reflejos	Fuerza 5/5 en MMSS; 4+/5 en flexores de cadera y rodilla bilateral. Reflejos osteotendinosos: rotulianos y aquileos 3/4 bilateralmente; signo de Babinski bilateral presente.
Sensibilidad	Hipoestesia táctil y termoalgésica con nivel sensitivo T10 incompleto (mayor a la izquierda). Palestesia (vibración) disminuida en maléolos. Signo de Lhermitte positivo.
Coordinación y Marcha	Disimetría leve talón-rodilla. Marcha en tándem insegura con lateropulsión. Romberg negativo.

Resultados de Estudios (Entregados en Mesa de Discusión)

- **RM cerebral con Gd:** 6 lesiones ovoides hiperintensas T2/FLAIR: 3 periventriculares perpendiculares al cuerpo calloso (dedos de Dawson), 1 juxtacortical frontal derecha, 1 en pedúnculo cerebeloso medio derecho. *Ninguna capta gadolinio.*
- **RM de columna dorsal con Gd:** Lesión focal T2 posterolateral en T8-T9 (< 1 segmento vertebral) que **capta gadolinio intensamente.**
- **Punción Lumbar / LCR:** 6 leucocitos/mm³ (linfocitos), glucosa normal, proteínas 42 mg/dL. **Bandas oligoclonales tipo 2 positivas (exclusivas del LCR).**
- **Serología celular (CBA):** Anticuerpos **anti-AQP4 (IgG)** y **anti-MOG (IgG): Negativos.**

GUÍA DE TRABAJO Y DEBATE SOCRÁTICO

● ETAPA 1 — KNOW: IDENTIFICACIÓN Y TOPOGRAFÍA DEL EVENTO ACTUAL

1. ¿Cumple este episodio la definición operativa de *brote desmielinizante*? Cite 3 argumentos del caso que lo fundamenten.

2. Diagnóstico topográfico: ¿Dónde radica la lesión responsable de la clínica actual? ¿Qué sustrato tiene el signo de Lhermitte?

3. La paciente nota que al bañarse con agua caliente se le "empaña" la visión en OD. ¿Qué fenómeno es y por qué no es un nuevo brote?

● ETAPA 2 — REASON: RECONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL Y HALLAZGOS SUBCLÍNICOS

4. ¿Qué datos del examen físico prueban objetivamente que la neuritis óptica de hace 14 meses existió y dejó secuela estructural?

5. ¿Qué alteración presenta la motilidad ocular conjugada, qué haz anatómico está lesionado y qué aporta a la localización?

6. Con la clínica y el examen físico solamente (sin ver imágenes), ¿podemos afirmar diseminación en tiempo (DIT) y espacio (DIS)? Justifique.

● ETAPA 3 — REASON: CRITERIOS MCDONALD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CRÍTICO

7. Aplique los Criterios de McDonald 2017 a la RM: ¿Qué regiones anatómicas cumplen DIS? ¿Cómo se demuestra DIT en esta sola resonancia?

8. Si la RM ya demostraba DIS y DIT, ¿cuál es el valor clínico y de seguridad de haber obtenido bandas oligoclonales en LCR?

9. EL GIRO CRÍTICO: Si la RM medular mostrara una mielitis longitudinalmente extensa (T3 a T8) y la neuritis previa hubiera dejado amaurosis residual (20/200), ¿en qué patología pensaría y qué fármacos habituales de EM estarían contraindicados?

● ETAPA 4 — ACT: CONDUCTA EN LA GUARDIA Y PLAN AL ALTA

10. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este brote agudo (fármaco y posología) y qué objetivo clínico real se busca?

11. ¿Qué educación preventiva le da a la paciente si en el futuro presenta fiebre o infección urinaria y reaparecen sus parestesias?

12. Plan al alta: ¿Cuáles son las tres acciones prioritarias que deben programarse con el servicio de Neurología?

TICKET DE SALIDA INDIVIDUAL (Entregar al docente antes de salir)

Estudiante: _____ | Fecha:

22/09/2026

1. Defina operativamente un brote desmielinizante en una sola frase:

2. Mencione 2 rasgos clínicos o de imagen que orientan fuertemente a NMOSD en vez de Esclerosis Múltiple:

a)

b)

3. ¿Cómo se explora el DPAR (linterna oscilante) y qué respuesta pupilar patológica se observa en el ojo afectado?